O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-7: Ko‘ruv a’zosining shikastlarida tez tibbiy yordam ko‘rsatish va hamshiralik parvarishi. Oftalmologik ekspertiza

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda kontuzion shikastlarda birinchi yordam ko‘rsatish, bir yoki ikki ko‘zga bog‘lam qo‘yish, bemorlarni operatsiyaga tayyorlash va keyingi parvarish hamda oftalmologik ekspertiza uchun ko‘rish funksiyalarini tekshirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Kontuzion shikast va kuyishlarda birinchi yordam
2. Bir yoki ikki ko‘zga bog‘lam qo‘yish, operatsiyaga tayyorlash va keyingi parvarish
3. O‘sma bemorlarini parvarish qilish va oftalmologik ekspertizada hamshira ishi

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Kontuzion shikastda birinchi yordam ko‘rsatadi.
- Bir yoki ikki ko‘zga bog‘lam qo‘yadi.
- Bemorni shoshilinch operatsiyaga tayyorlaydi va keyingi parvarishni bajaradi.
- O‘sma bemorlarini parvarish qilish va ekspertiza tekshiruvlarini tushuntiradi.

Tayanch so‘zlar

kontuziya, birinchi yordam, sovuq qo‘yish, ko‘zni yuvish, binokulyar bog‘lam, shoshilinch operatsiya, ekspertiza.

1. Kontuzion shikast va kuyishlarda birinchi yordam

Koʻz shikastida hamshira birinchi boʻlib bemorga duch keladi. Uning aniq va xotirjam harakati koʻrishni saqlab qolishi mumkin. Har qanday shikastda ketma-ketlik bir xil: bemorni tinchlantirish, shikast sababi va vaqtini aniqlash, koʻrish oʻtkirligini tekshirish, koʻzning tashqi holatini koʻrish, shoshilinch yordam koʻrsatish, hujjatni rasmiylashtirish va kerak boʻlsa, ixtisoslashgan boʻlimga yuborish. Koʻz olmasi teshilishiga shubha boʻlsa, koʻz bosilmaydi va yuvilmaydi.

Kontuzion shikastda birinchi yordam

Jihozlar: muzli xaltacha, salfetka, 0,1% adrenalin (koʻrsatma bilan), antiseptik tomchi, steril bint, doka

1. Bemorni tinchlantiring, oʻtqazing yoki yotqizing.
2. Shikast vaqti va mexanizmini soʻrang.
3. Koʻrish oʻtkirligini avval sogʻlom, keyin shikastlangan koʻzda tekshiring.
4. Qovoq, konʼyunktiva, oldingi kamera va qorachiqni koʻzdan kechiring.
5. Birinchi soatlarda muzli xaltachani salfetkaga oʻrab, 10–15 daqiqa qoʻying, oraliq bilan takrorlang.
6. Koʻrsatma bilan adrenalin va antiseptik tomchi tomizing.
7. Oʻrta va ogʻir darajada binokulyar bogʻlam qoʻying.
8. Bemorni yotgan holatda koʻz boʻlimiga yuboring, hujjatni yozing.

Koʻzning holatini baholash

Belgi	Nimani koʻrsatadi	Harakat
Koʻrish pasaymagan, qovoq koʻkargan	Yengil kontuziya	Sovuq, kuzatuv
Oldingi kamerada qon	Gifema, oʻrta daraja	Yarim oʻtirgan holat, bogʻlam, statsionar
Qorachiq keng	Sfinkter shikasti	Statsionar
Koʻrish keskin pasaygan	Ogʻir daraja, koʻchish, gemoftalm	Zudlik bilan boʻlimga
2–3 kunda “koʻzoynak belgisi”	Bosh suyagi asosi singishi	Neyroxirurg, shoshilinch
Yara, ichki pardalar koʻrinadi	Teshib oʻtgan yara	Bosmaslik, bogʻlam, shoshilinch

Gifemada bemor yarim oʻtirgan holatda saqlanadi, shunda qon pastga choʻkadi va qorachiqni yopmaydi. Bemorga jismoniy faollik cheklanadi. Shox parda eroziyasida anestetik tomchi faqat koʻrik uchun qoʻllaniladi, keyin antibiotikli malham va yengil bogʻlam qoʻyiladi. Kontuziyada koʻz ichi bosimi palpator tekshiriladi, agar u past boʻlsa, bemor koʻz boʻlimiga yuboriladi, ammo teshib oʻtgan yaraga shubhada bu tekshiruv bajarilmaydi.

Kuyishda amaliy harakatlar

Kuyishda koʻzni yuvish

Jihozlar: toza suv yoki fiziologik eritma, shprits yoki rezina ballon, lotok, tampon, anestetik tomchi

1. Yuvishni darhol boshlang, boshqa muolajalarni kechiktiring.
2. Bemor boshini kuygan koʻz tomonga egdiring.
3. Qovoqlarni bosh va koʻrsatkich barmoq bilan oching.
4. Bemor har tomonga qarab tursin, oqimni ichki burchakdan tashqariga yoʻnaltiring.
5. Yuqori qovoqni agʻdarib, qoldiqlarni nam paxta bilan oling.
6. Yuvishni 20–30 daqiqa davom ettiring.
7. Koʻrsatma bilan tomchilar va malham qoʻying, bogʻlam qoʻying, boʻlimga yuboring.

Termik kuyishda ham koʻz sovuq suv bilan yuviladi, kuygan qovoqlarga steril malham surtiladi. Oftob va payvandlash nurlaridan kuyishda bemor qorongʻi xonada saqlanadi, sovuq kompress, anestetik va namlovchi tomchilar qoʻllaniladi. Hamshira bemorga kimyoviy modda nomini aniqlash, ishdan yoki uydan namunani yoki idishni olib kelishni soʻraydi, ammo buning uchun yuvishni toʻxtatmaydi. Noma’lum modda bilan zararlanish ogʻir shikast deb qabul qilinadi.

Mashgʻulotda xavfsizlik

Barcha shikast holatlari mulyajda yoki vaziyatli oʻyin shaklida koʻrib chiqiladi. Koʻzga real yuvish faqat fiziologik eritma bilan oʻquvchi roziligi asosida va oʻqituvchi nazoratida bajariladi. Har bir oʻquvchi algoritmni ogʻzaki aytib beradi, keyin amalda koʻrsatadi.

2. Bir yoki ikki koʻzga bogʻlam qoʻyish, operatsiyaga tayyorlash va keyingi parvarish

Bogʻlam koʻzni qoʻshimcha shikast va infeksiyadan himoya qiladi, koʻz harakatini cheklab, tinchlik yaratadi. Shikastda koʻpincha binokulyar bogʻlam qoʻyiladi, chunki ikki koʻz birga harakatlanadi: sogʻlom koʻz harakati shikastlangan koʻzga ham ta’sir qiladi. Bogʻlam koʻzni bosmasligi kerak, ayniqsa teshib oʻtgan yarada.

Bir koʻzga bogʻlam qoʻyish

Jihozlar: steril doka salfetka, paxta, bint, qaychi

1. Qoʻlni yuving, bemorga tushuntiring.
2. Koʻzga steril salfetka va paxta qoʻying.
3. Bintni peshona atrofidan 2 marta aylantiring.
4. Ensadan quloq ostidan koʻz ustiga qiyshiq oʻtkazing.
5. Aylanma va qiyshiq oʻramlarni navbatlang.
6. Peshonada mahkamlang.

Ikki ko‘zga (binokulyar) bog‘lam qo‘yish

Jihozlar: 2 ta doka yostiqcha, bint, qaychi

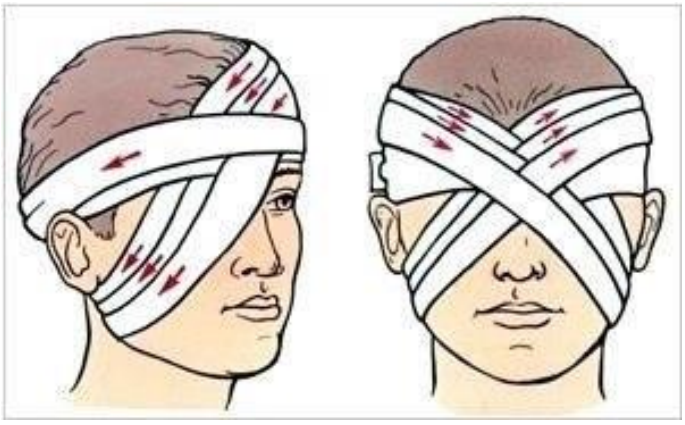
1. Ikki ko‘zga yostiqcha qo‘ying, bemorga nima bo‘layotganini ayting.
2. Bintni peshona atrofidan mahkamlang.
3. Ensadan quloq ostiga, o‘ng ko‘zga, peshonaga o‘tkazing.
4. Peshonadan chap ko‘zga, quloq ostidan ensaga o‘tkazing.
5. O‘ramlarni qiyshiq krest shaklida navbatlang.
6. Bog‘lamni mahkamlang: barmoq sig‘sin, quloq ochiq bo‘lsin.
7. Bemorni yetaklab, xavfsizligini ta’minlang.

Shoshilinch operatsiyaga tayyorlash

Ko‘z yaralanishi va yot jism shoshilinch operatsiyani talab qiladi. Hamshira tezkor harakat qiladi: qon guruhi va umumiy tahlillarni oladi, qoqsholga qarshi emlash holatini aniqlaydi, bemorning oxirgi ovqatlanish vaqtini so‘raydi, chunki operatsiya umumiy og‘riqsizlantirish ostida bajarilishi mumkin. Rentgen va ultratovush tekshiruviga kuzatib boradi. Allergiya va doimiy qabul qilinadigan dorilar so‘raladi. Rozilik varaqasi rasmiylashtiriladi, voyaga yetmaganlar uchun ota-ona imzolaydi. Ko‘z yuvilmaydi, kipriklar qirqilmaydi, faqat shifokor ko‘rsatmasi bilan muolaja bajariladi.

Operatsiyadan keyingi parvarish

- Bemorni ehtiyotkorlik bilan o‘ringa ko‘chirish, ko‘rsatilgan holatda yotqizish.
- Bog‘lamni kuzatish, qonash va namlanishda shifokorga xabar berish.
- Antibiotik va yallig‘lanishga qarshi tomchilarni belgilangan tartibda tomizish.
- Harorat, og‘riq, ko‘rish va umumiy holatni qayd etish.
- Ovqat yumshoq, ich qotishining oldini olish, yo‘tal va kuchanishni cheklash.
- Sog‘lom ko‘zdagi qizarish yoki ko‘rish pasayishini kuzatish: simpatik oftalmiya xavfi.



Bir va ikki ko‘zga qo‘yiladigan bog‘lamlar

Bemor shikast tufayli ruhiy zo‘riqishda bo‘ladi: ko‘rishni yo‘qotish qo‘rquvi, ishini yo‘qotish xavotiri, tashqi ko‘rinish o‘zgarishi. Hamshira uni diqqat bilan tinglaydi, savollariga aniq javob beradi, oila a’zolarini jalb qiladi. Bemor uyga chiqarilganda yozma tavsiya, kuzatuv muddati, himoya ko‘zoynagi va ishga qaytish tartibi tushuntiriladi.

Bog‘lam qo‘yilgandan keyin bemorda bosh aylanishi yo‘qligi va og‘riq kuchaymagani tekshiriladi. Binokulyar bog‘lamli bemor yolg‘iz yurmaydi, u qo‘lidan ushlab, ogohlantirib olib boriladi. Bog‘lam nam bo‘lsa yoki siljisa, almashtiriladi. Tashish vaqtida bemor yoki uning yaqinlariga kuzatuv muddati aytiladi.

3. O‘sma bemorlarini parvarish qilish va oftalmologik ekspertizada hamshira ishi

Ko‘z o‘smasi bilan og‘rigan bemor uzoq davolanadi. Hamshira uning tekshiruvlar va operatsiyaga tayyorgarligi, nur va kimyoterapiya davridagi parvarishi, ruhiy holatiga e’tibor beradi. Bemor bilan muloqot deontologiya qoidalariga mos bo‘lishi kerak: tashxisni shifokor aytadi, hamshira esa bemorni qo‘llab-quvvatlaydi va tartibni tushuntiradi.

O‘sma bemorlari parvarishi

- Tekshiruvlarga (ultratovush, KT, MRT, biopsiya) tayyorlash, maqsadini tushuntirish.
- Operatsiyadan oldingi umumiy tayyorgarlik va rozilik varaqasini rasmiylashtirish.
- Enukleatsiyadan keyin bosuvchi bog‘lam, tomchilar va og‘riqni nazorat qilish.
- Nur terapiyasida teri va kon’yunktivani kuzatish, namlovchi tomchilar.
- Kimyoterapiyada ko‘ngil aynishi, qon ko‘rsatkichlari va infeksiya belgilarini kuzatish.
- Dispanser kuzatuvi: jigar va boshqa a’zolar tekshiruvi muddatlarini eslatish.
- Bolalar va ota-onalarga ruhiy yordam, psixolog bilan hamkorlik.

Oftalmologik ekspertizada hamshira ishi

Ekspertiza uchun bemorning ko‘rish funksiyalari to‘liq va ishonchli baholanadi. Hamshira hujjatlarni tayyorlaydi: ambulator karta, tekshiruv natijalari, shifokor xulosasi, ishlash joyidan ma’lumotnoma va ishlab chiqarish shikasti akti. Tekshiruv quyidagilarni o‘z ichiga oladi: tuzatishsiz va tuzatish bilan ko‘rish o‘tkirligi, ko‘ruv maydoni, ko‘z ichi bosimi, refraksiya, rang va binokulyar ko‘rish, ko‘z tubi.

Ekspertiza uchun ko‘rish funksiyalarini tekshirish

Jihozlar: Sivtsev–Golovin jadvali, sinov linzalari, perimetr, Rabkin jadvallari, tonometr

1. Hujjatlarni va bemor shaxsini tekshiring.
2. Tuzatishsiz ko‘rish o‘tkirligini har bir ko‘zda aniqlang.
3. Eng yaxshi tuzatish bilan ko‘rish o‘tkirligini yozing.
4. Ko‘ruv maydoni tekshiruviga yuboring.
5. Rang va binokulyar ko‘rishni tekshiring.
6. Ko‘z ichi bosimini o‘lchashni tashkil eting.

7. Natijalarni aniq, tuzatishsiz yozing va shifokorga topshiring.

Simulyatsiyani aniqlash sinamalari

Ko‘rishi pasayganini da’vo qilgan shaxsda shifokor maxsus sinamalar bajaradi. Qorachiq reaksiyasi saqlanganligi, yorug‘lik bilan to‘g‘ri va hamkor reaksiya tekshiriladi. Linzalar bilan tekshirishda kuchli va kuchsiz linzalar almashtiriladi va javoblar solishtiriladi. Prizma sinamasida ko‘z oldiga prizma qo‘yilganda ko‘z harakati kuzatiladi. Bir xil natijalar takrorlanmasa, bu shubha uyg‘otadi. Hamshira kuzatuvlarini tezkor yozadi, ammo bemorga qarama-qarshi gapirmaydi va xulosani shifokorga qoldiradi.

Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik va xulosalar

Shikast va operatsiyadan keyin bemorga kasallik varaqasi beriladi. Muddat kasallik og‘irligi va kasbga bog‘liq. Og‘ir ish, changli va issiq sharoitda ishlovchilar uzoqroq dam oladi. Agar ko‘rish tiklanmasa, bemor tibbiy-mehnat ekspert komissiyasiga yuboriladi. Komissiya nogironlik guruhini belgilaydi, hamshira esa zarur hujjatlarni tayyorlaydi va bemorni reabilitatsiya imkoniyatlari bilan tanishtiradi. Kasbni o‘zgartirish kerak bo‘lsa, ijtimoiy xodim bilan hamkorlik qilinadi. Hamshira hujjatlarda sana, vaqt va imzoni aniq qo‘yadi, tuzatishlarni belgilangan tartibda bajaradi.

Amaliy mashg‘ulot yakunida o‘quvchilar kichik guruhlarda shikast vaziyatlarini hal etadi, bog‘lamlarni qo‘yadi va ekspertiza hujjatining namunasini to‘ldiradi. O‘qituvchi har bir ko‘nikmani nazorat varag‘i bo‘yicha baholaydi.

Bemorning shaxsiy ma’lumotlari va tashxisi sir saqlanadi. Hamshira ekspertiza natijalarini faqat vakolatli shaxslarga beradi, hujjatlarni belgilangan tartibda saqlaydi. Hujjatdagi xatolar belgilangan tartibda tuzatiladi va imzo bilan tasdiqlanadi, chunki ular bemorning huquq va imtiyozlariga ta’sir qiladi.

Mashg‘ulotda o‘quvchilar ushbu hujjatlarni to‘g‘ri to‘ldirishni namunalar asosida mashq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.